

NOTULEN

HARI / TANGGAL : SENIN / 26 JANUARI 2026
 PUKUL : 09.00 WIB – SELESAI
 AGENDA RAPAT : RAPAT KOORDINASI VERIFIKATOR DI UNIT

PEMIMPIN RAPAT : dr. SEFRINA TRISADI, Sp.DVE
 NOTULIS : ADINDA LESTARI PUTRI, S.KM
 TEMPAT : LOKASI DINAS MASING MASING

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Kebutuhan verifikator di unit	1. Mapping untuk staf verifikator di unit	1. Di buat per lantai untuk staf verifikator di IRNA 2. Tidak di NS karena terlalu sempit 3. Di buat mobile menggunakan laptop 4. Verifikator per lantai, berkeliling dan pro aktif untuk kelengkapan klaim 5. Harus tetap ada yg stay di ruangan asuransi center, sehingga tim di bagi untuk tim lapangan dan tim di kantor untuk mengerjakan klaim 6. Harus ada pembagian jobdesk agar untuk tim lapangan bisa di fokuskan di kelengkapan 7. Bisa dilakukan rolling untuk tim lapangan maupun tim kantor	1. Verifikator 2. Manajemen RS

			(administrasi klaim) sehingga pembagian jobdesk rata 8. Tim lapangan harus punya catatan harian sebelum DPJP datang tentang apa saja yang harus di cek kan ke DPJP yang bertugas 9. Tim lapangan juga sekaligus dapat menjadi trainer untuk teman teman di unit pelayanan agar terpapar mengenai klaim 10. Target di mulai 1 februari dan di evaluasi setiap bulan Target dan sistem terlampir	
		Kelengkapan dan kebutuhan sarana verifikator di unit	1. Lengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan 2. Apabila mobile bisa menggunakan laptop 3. Koordinasi dengan IT terkait kebutuhan spesifikasinya 4. komputer yang tidak digunakan di unit asuransi center bisa di gunakan di unit untuk tim lapangan verif 5. apabila di butuhkan laptop untuk mobile bisa juga di ajukan	1. Verifikator 2. Manajemen RS
		Verifikator yang bertugas di kantor dalam proses klaim, apabila tim lapangan mengalami kendala	RS bisa mengeluarkan surat kebijakan bahwa	1. Verifikator

		terkait kelengkapan dokumen, akan berdampak pada penumpukan pekerjaan tim kantor, khususnya pada proses input klaim, karena harus menunggu kelengkapan tersebut	1. harus ada komitmen untuk penyelesaian administrasi klaim adalah 1x24 jam post KRS 2. verifikator akan ditempatkan di unit. 3. Apabila di temukan keterlambatan maka di beri sanksi untuk pengurangan jam konsulan.	2. Manajemen RS
--	--	---	---	-----------------

Pemimpin Rapat

Malang, 26 Januari 2026

Notulis



Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Adinda Lestari Putri, S.KM

**PERENCANAAN PENEMPATAN VERIFIKATOR ADMIN BPJS KESEHATAN
DI UNIT LAYANAN
SENIN, 26 JANUARI 2026
TARGET FEBRUARI BEJALAN & EVALUASI UNTUK KLAIM FEBRUARI**

Tujuan :

1. Perbaikan kualitas klaim : sistem, administrasi, klinis, koding
2. Pemenuhan indikator mutu klaim sesuai dengan yang telah disepakati

Target :

SISTEM	ADMINISTRASI	KLINIS	KODING
Klaim sesuai persyaratan mutlak dan teknis	Kepesertaan, Pelayanan & Penunjang, Keuangan lengkap semua	Ketepatan anamnesis, pemeriksaan fisik, tata laksana semua in line dengan diagnosis sesuai dengan regulasi (PNPK / PPK CP / PMK)	Koding diagnosis & tindakan sesuai aturan

Langkah :

1. Membuat jadwal verifikator admin BPJS di unit IRNA : Lantai 2 (2A, 2B, Mater, Neo, NICU) dan Lantai 3 (ICU, 3A, 3B), dan asuransi center
2. Pertimbangan jadwal non shift, bisa dirolling mingguan / 2 mingguan
3. Lokasi : sesuai dengan lapangan
4. Sosialisasi ke DPJP dan perawat IRNA bahwa sekarang ada verifikator di unit, untuk memudahkan koordinasi terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas pasien BPJS + kebijakan direktur bahwa kelengkapan dokumen baik administrasi, klinis maksimal 1 x 24 jam
5. Bila ditemukan ketidakdisiplinan dalam pengisian eRM, dimasukkan dalam evaluasi dokter
6. Membuat list kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan di unit (meja, komputer/laptop, dll)

Tugas harian verifikator di unit :

1. Memeriksa kelengkapan dokumen rekam medis sesuai dengan ketentuan klaim
2. Menulis temuan tiap DPJP, dilist PR nya apa saja dan apa yang perlu didiskusikan disampaikan ketika DPJP visite
3. Selalu cek pengkajian di IGD setiap ada OB, bila ada temuan tidak lengkap / tidak sesuai langsung koordinasi dengan dokter IGD terkait
4. Selama pasien dirawat, koordinasi dengan DPJP langsung atau melalui case manager (dr. Tamara) bila ada temuan ketidak sesuaian proses klinis dengan diagnosis
5. Bila DPJP visite sore / di luar jam verifikator standby, beri notes dan titipkan ke perawat yang jaga
6. Bila ditemukan pasien dengan diagnosis yang sudah ada PPK nya, selalu cek antara klinis & PPK. Kalau ada yang melenceng langsung didiskusikan bersama

Tugas harian verifikator di asce :

1. Berjalan seperti biasa, sebagai finalisasi berkas yang dikirim ke BPJS (target pengerjaan harus lebih cepat)